OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION - CE DOCUMENT N'EST PAS UN DIAGNOSTIC

Rapport d'analyse radiographique

Analyse n°	1
Date	13/10/2026 23:19 UTC
Fichier	radio.png
Résultat	Pneumonie suspectée
Probabilité de pneumonie	96,3 %
Type estimé	Type de pneumonie non évalué

Pistes de prise en charge à discuter (suggestions)

Le modèle déployé détecte la pneumonie mais n'estime pas son type.

Examens pour confirmer et préciser

- Examen clinique, constantes et saturation en oxygène
- NFS, CRP (± procalcitonine)
- Recherche virale selon le contexte (grippe, SARS-CoV-2, VRS)
- Hémocultures et autres examens si forme sévère

Traitement : points à considérer

- Ne pas décider du traitement sur la seule base de ce rapport.
- La décision d'antibiothérapie probabiliste revient au médecin, selon la gravité, l'âge, le terrain et les résultats biologiques.

Mesures de soutien

- Hydratation, repos, antipyrétique/antalgique adapté à l'âge
- Oxygénothérapie si hypoxémie

Suivi

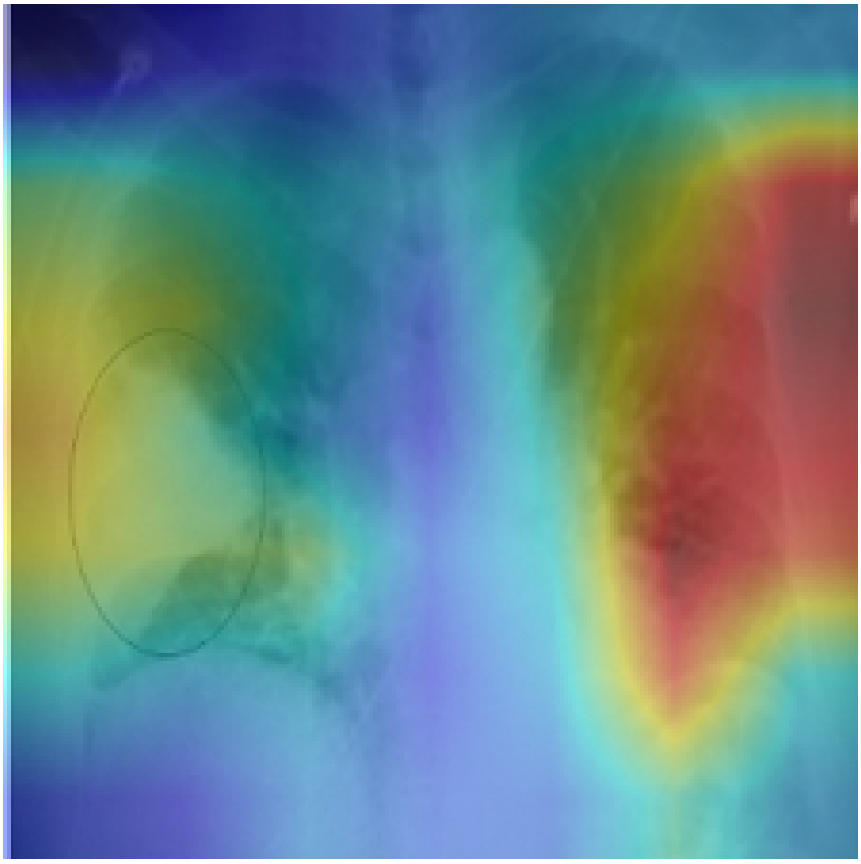
- Réévaluer à 48-72 h ou plus tôt en cas d'aggravation

Signes de gravité : évaluation urgente

- Saturation en oxygène basse (environ moins de 92 à 94 %) ou besoin d'oxygène
- Respiration rapide, tirage, geignement, cyanose, signes de détresse respiratoire
- Confusion, somnolence, hypotension, déshydratation, impossibilité de boire ou de s'alimenter
- Nourrisson très jeune, immunodépression, comorbidité grave, échec d'un traitement après 48 à 72 h
- Un ou plusieurs de ces signes justifient une évaluation en urgence et souvent une hospitalisation

Limites : Le type est estimé à partir de l'image seule. Même pour des radiologues, distinguer une pneumonie bactérienne d'une pneumonie virale sur une radiographie est difficile, et le germe exact (pneumocoque, Mycoplasma, virus de la grippe, SARS-CoV-2, VRS, aspiration, champignon...) ne peut pas être identifié ainsi. Le modèle a été entraîné sur des radiographies pédiatriques d'un seul centre : sa fiabilité chez l'adulte n'est pas établie.

Zones influençant la prédiction (Grad-CAM)



Les zones rouges et jaunes sont celles qui ont le plus pesé dans la décision du modèle.

Avertissement. Ce rapport est généré automatiquement par un modèle d'intelligence artificielle. Il constitue une aide à la lecture destinée à un professionnel de santé et ne constitue en aucun cas un diagnostic médical ni une prescription. Seul un médecin, après examen clinique et analyse de la radiographie, peut poser un diagnostic et décider d'un traitement. Les pistes de prise en charge sont des rappels généraux, sans posologie, à adapter au patient.